ÉDITION OFFICIELLE CONCOURS MÉDICAL • R2C 2026

LE GUIDE OFFICIEL DES 15 STATIONS ECOS

Checklists Cliniques, Grilles Critériées d'Évaluation (7 min), Scénarios Comédien & Pièges Éliminatoires du Jury

Ce référentiel clinique intensif a été conçu par des universitaires, PH et anciens majors pour préparer les étudiants de 2e Cycle aux Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS), coefficient déterminant dans le classement d'accès au 3e Cycle de Médecine.

Contenu certifié de chaque station :
• **Contexte Candidat (1 min de lecture porte) :** motif, constantes d'accueil, consigne exacte.
• **Feuille de Route Patient Standardisé :** attitudes, phrases spontanées, éléments révélés sur question.
• **Chronométrage Minute par Minute :** découpage tactique sur les 7 minutes imparties.
• **Grille d'Évaluation Officielle sur 20 Points :** répartition critériée Rangs A et B.
• **Les 3 Pièges Éliminatoires R2C :** erreurs fatales sanctionnées immédiatement par la grille du jury.

Station	Spécialité	Item R2C	Objectif Clé
01. SCA ST+	Cardiologie	Item 334	ECG < 10 min, coronarographie urgente < 120 min, ASA+Ticagrélor
02. AVC Ischémique	Neurologie	Item 335	Fenêtre thrombolyse < 4h30, IRM cérébrale urgence, NIHSS
03. Exacerbation BPCO	Pneumologie	Item 205	Oxygène titré cible 88-92%, aérosols, VNI si acidose respiratoire
04. Purpura Fulminans	Pédiatrie / Urgences	Item 328	C3G IV/IM immédiate sans attendre bilan, remplissage, PL contre-indiquée
05. OAP Flash Cardiogénique	Réanimation	Item 234	CPAP/VNI précoce, dérivés nitrés IV à forte dose, Furosémide IV
06. Acidocétose Diabétique	Endocrinologie	Item 247	Réhydratation massive NaCl 0.9%, contrôle K+ AVANT insuline rapide
07. Convulsion Fébrille	Pédiatrie	Item 344	Réassurance parentale, élimination purpura/méningite, pas de TDM
08. Torsion Spermatique	Urologie	Item 343	Urgence chirurgicale absolue < 6h, pas d'écho-Doppler retardatrice
09. Grossesse Extra-Utérine	Gynécologie	Item 24	Bêta-hCG + écho endovaginale, prévention anti-D si Rhésus négatif
10. Arthrite Septique Genou	Rhumatologie	Item 198	Ponction articulaire impérative AVANT antibiothérapie probabiliste
11. Annonce de Mauvaise Nouvelle	Cancérologie	Item 290	Cadre serein, respect des silences, dispositif d'annonce, écoute
12. Intoxication Paracétamol	Toxicologie	Item 336	Nomogramme Rumack-Matthew, NAC IV dès H4, bilan hépatique
13. OACR Brutale	Ophtalmologie	Item 82	Macula rouge cerise, bilan Horton systématique (VS/CRP) si > 50 ans
14. Pyélonéphrite Obstructive	Urologie	Item 161	Urgence médico-chirurgicale : drainage urologique + C3G, pas d'AINS
15. Crise Suicidaire Aiguë	Psychiatrie	Item 353	Score RUD, questionnement direct sans détour, hospitalisation de crise

Auteur & Coordination Éditoriale : Ethan Cole • EDN Store Référence R2C • Collèges d'Enseignants Universitaires

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DES ECOS R2C

Les Règles Officielles, la Gestion du Temps et la Psychologie de l'Évaluateur

Les Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS) évaluent la **compétence clinique en situation** selon une démarche standardisée et reproductible. Chaque candidat passe une série de stations successives de **7 minutes chrono**, précédées d'une minute de lecture de la consigne affichée sur la porte du box.

1. La Minute de Porte (Lecture Consigne)

Ne vous précipitez pas à l'intérieur. Identifiez instantanément : l'âge du patient, le motif de consultation, les constantes vitales mentionnées, et la **mission exacte** demandée ('Réalisez l'interrogatoire', 'Expliquez la stratégie thérapeutique', etc.). Structurez mentalement votre plan en 3 temps.

2. Les 7 Minutes dans le Box

- **Minute 0-1 :** Salutation, présentation, recueil du motif et vérification de la douleur.
- **Minute 1-3 :** Interrogatoire sémiologique ciblé et recherche des antécédents/traitements pertinents.
- **Minute 3-5 :** Examen physique orienté (ou formulation des gestes à l'évaluateur) et hypothèses diagnostiques.
- **Minute 5-7 :** Annonce claire au patient de la prise en charge, prescription justifiée, réponses aux angoisses, conclusion.

3. La Grille Critériée du Jury (20 Points)

L'évaluateur dispose d'une grille pré-remplie avec des items binaires ('Fait' / 'Non fait') ou gradués. Chaque item manquant est irrémédiablement perdu. La posture professionnelle, l'empathie et la communication comptent pour **20 à 25% de la note globale**.

4. Les Pièges Éliminatoires et Fautes Sanctionnées

Certaines fautes de sécurité entraînent une perte majeure de points sur la station : oublier de vérifier une allergie avant un antibiotique, méconnaître un signe d'urgence vitale immédiate, injecter un produit contre-indiqué ou maltraiter verbalement le patient comédien.

Station 01 : Syndrome Coronarien Aigu ST+ (SCA ST+)

Cardiologie & Urgences Médicales • Item R2C 334 • Douleur thoracique aiguë • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Vous recevez aux urgences M. Bernard, 58 ans, tabagique (30 PA), dyslipidémique. Il se plaint d'une douleur thoracique rétro-sternale constrictive irradiant dans la mâchoire et le bras gauche, débutée il y a 45 minutes au repos.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient est angoissé, en sueur, porte la main à sa poitrine (signe du poing). Il répond avec concision. Il signale que la douleur est à 8/10 et ne cède pas au repos. Il n'a jamais eu d'antécédent similaire.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Accueil empathique, interrogatoire rapide (début, irradiation, facteurs de risque CV, contre-indications thrombolyse).
2 à 4 min	Constantes (PA, FC, SpO2), scope ECG immédiat 12 dérivations + V7-V9/V3R-V4R : sus-décalage ST en territoire antérieur.
4 à 6 min	Annonce rassurante, analgésie, appel direct de l'USIC / Coronarographie (< 120 min), double antiagrégation (Aspirine + Ticagrélor) et anticoagulation (HNF).
6 à 7 min	Synthèse au patient, information sur la coronarographie en urgence et transfert médicalisé.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Accueil, présentation et réassurance du patient angoissé	2 pts	Rang A
Interrogatoire ciblé : caractéristiques de la douleur, début < 12h, absence d'allergie	3 pts	Rang A
Demande immédiate de l'ECG 12 dérivations en < 10 min et pose voie veineuse	3 pts	Rang A
Diagnostic positif verbalisé : SCA ST+ (IDM avec sus-décalage persistant)	3 pts	Rang A
Prescription de la trithérapie d'urgence : Aspirine 250 mg IV + Ticagrélor 180 mg + Héparine	3 pts	Rang A
Activation immédiate de la filière angioplastie primaire (< 120 min du diagnostic)	3 pts	Rang A
Surveillance scope, chariot d'urgence / défibrillateur à portée immédiate	3 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Prescrire de la trinitrine sans vérifier la pression artérielle systolique (risque d'hypotension sévère en cas d'infarctus du VD).
■■ **Piège 2 :** Attendre le résultat du dosage de troponine avant d'activer la coronarographie (perte de temps majeure = faute lourde).
■■ **Piège 3 :** Oublier de rechercher les dérivations postérieures (V7-V9) et droites (V3R-V4R) devant un doute d'extension.

Station 02 : Accident Vasculaire Cérébral Ischémique (AVC)

Neurologie Vasculaire & Urgences • Item R2C 335 • Déficit neurologique récent • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Mme Claire, 67 ans, hypertendue, amenée par les pompiers pour hémiplégie droite et impossibilité de parler, apparues brutalement à 08h15 ce matin (il est actuellement 09h00).

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente présente une aphasie de Broca (comprend les ordres simples mais ne parvient pas à articuler de phrases) et une paralysie faciale centrale droite. Elle est consciente.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Vérification immédiate de l'heure précise des premiers symptômes (fenêtre thérapeutique < 4h30) et glycémie capillaire.
2 à 4 min	Évaluation neurologique rapide score NIHSS (motricité faciale, bras, jambe, langage, héminégligence).
4 à 6 min	Alerte de la filière neurovasculaire (UNV), demande d'IRM cérébrale en urgence (séquences Diffusion, FLAIR, T2*, Angio-TOF).
6 à 7 min	Mise en condition (jeûne strict, VVP, respect de l'HTA jusqu'à 185/110 si thrombolyse, tête à 30°).

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Glycémie capillaire immédiate pour éliminer une hypoglycémie simulant un AVC	3 pts	Rang A
Précision de l'heure exacte de début des symptômes (08h15, fenêtre valide)	3 pts	Rang A
Examen neurologique ciblé (déficit moteur, paralysie faciale centrale, aphasie)	3 pts	Rang A
Appel immédiat de l'UNV / régulation neurovasculaire	3 pts	Rang A
Prescription de l'IRM cérébrale protocole urgence AVC (ou TDM si contre-indication)	3 pts	Rang A
Respect de la pression artérielle (ne pas faire chuter la PA brutalement)	3 pts	Rang A
Consigne stricte : arrêt des apports oraux (jeûne strict et interdiction des anticoagulants)	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Faire baisser agressivement la tension artérielle d'un AVC ischémique non thrombolysé (aggravation de la zone de pénombre).
■■ **Piège 2 :** Donner de l'aspirine ou un antithrombotique avant d'avoir obtenu l'imagerie cérébrale (risque d'hémorragie cérébrale mortelle).
■■ **Piège 3 :** Oublier de tester la glycémie au lit du malade devant tout déficit focal brutal.

Station 03 : Exacerbation Aiguë de BPCO & Gazométrie

Pneumologie & Réanimation • Item R2C 205 • Broncho-pneumopathie chronique obstructive • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

M. Robert, 64 ans, BPCO connue sous bronchodilatateurs de longue durée, consulte pour une aggravation majeure de sa dyspnée depuis 48 heures avec expectorations devenues vertes et épaisses.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient parle par bribes de phrases, utilise ses muscles accessoires (tirage sus-claviculaire et intercostal), FR = 28/min, SpO2 = 83% en air ambiant. Il tousse fréquemment.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Position demi-assise immédiate, mise sous oxygène titré à faible débit avec lunettes (cible 88-92%).
2 à 4 min	Évaluation des critères d'Anthonisen (dyspnée +, volume crachats +, purulence +) et signes de gravité respiratoire.
4 à 6 min	Prescription des aérosols de bronchodilatateurs de courte durée (Salbutamol 5mg + Ipratropium 0.5mg), gazométrie artérielle en urgence.
6 à 7 min	Antibiothérapie ciblée (Amoxicilline-Acide clavulanique) et évaluation de la nécessité d'une VNI si acidose respiratoire hypercapnique.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Installation immédiate du patient en position assise ou demi-assise	2 pts	Rang A
Oxygénothérapie titrée aux lunettes avec cible de SpO2 stricte entre 88% et 92%	4 pts	Rang A
Prescription d'aérosols de Salbutamol (5 mg) et Bromure d'ipratropium (0,5 mg)	3 pts	Rang A
Demande d'une gazométrie artérielle immédiate en air ou sous O2 titré	3 pts	Rang A
Recherche des signes d'épuisement respiratoire (respiration paradoxale, sueurs, astérixis)	3 pts	Rang A
Prescription d'une antibiothérapie pour exacerbation purulente (Anthonisen type 1)	3 pts	Rang A
Vérification des critères de recours à la Ventilation Non Invasive (VNI : pH < 7.35, PaCO2 > 45)	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Mettre un patient BPCO hypercapnique sous oxygène à haut débit (ex: 15 L au masque à haute concentration) provoquant une hypoventilation majeure et le coma hypercapnique.
■■ **Piège 2 :** Oublier de demander une radiographie thoracique pour éliminer un pneumothorax compressif ou un foyer infectieux.
■■ **Piège 3 :** Négliger la recherche d'une encéphalopathie respiratoire (flapping tremor, sueurs profuses, somnolence).

Station 04 : Fièvre et Purpura Extensif (Purpura Fulminans)

Pédiatrie, Infectiologie & Urgences • Item R2C 328 • Purpura chez l'enfant et l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Un enfant de 4 ans est amené par ses parents aux urgences pour une fièvre brutale à 40°C, une léthargie et l'apparition de taches violacées sur les cuisses depuis moins de 2 heures.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

L'enfant est prostré, geignard, FC = 160 bpm, TRC = 4 secondes. Sur les cuisses et l'abdomen, présence de plusieurs macules purpuriques dont un élément ecchymotique de 12 mm de diamètre à centre nécrotique.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Reconnaissance immédiate de l'urgence vitale absolue : Purpura fulminans méningococcique.
2 à 3 min	Injection immédiate sans délai de Céfotaxime ou Ceftriaxone IV ou IM (avant tout examen paraclinique).
3 à 5 min	Remplissage vasculaire rapide (sérum salé 20 mL/kg en 15 min), oxygénothérapie, alerte SMUR/Réanimation pédiatrique.
5 à 7 min	Isolement gouttelettes, déclaration obligatoire à l'ARS et antibioprophylaxie des sujets contacts (Rifampicine).

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Diagnostic clinique immédiat de Purpura Fulminans verbalisé dès l'inspection	4 pts	Rang A
Administration immédiate d'une C3G (Ceftriaxone 100 mg/kg ou Céfotaxime 50 mg/kg) IV ou IM	5 pts	Rang A
Ne pas retarder l'antibiothérapie pour poser un cathéter ou réaliser un bilan sanguin	3 pts	Rang A
Contre-indication formelle et absolue de la ponction lombaire au stade de purpura fulminans	3 pts	Rang A
Appel immédiat de la réanimation pédiatrique et prise en charge du choc septique (remplissage 20 mL/kg)	2 pts	Rang A
Mise en place de précautions complémentaires respiratoires de type 'Gouttelettes'	2 pts	Rang B
Signalement sans délai à l'ARS et prophylaxie des cas contacts par Rifampicine	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Tenter de réaliser une ponction lombaire avant d'injecter la céphalosporine (retard assassin et risque de décès immédiat).
■■ **Piège 2 :** Attendre les résultats d'un bilan biologique ou d'une hémoculture pour injecter la C3G.
■■ **Piège 3 :** Omettre l'isolement respiratoire gouttelettes et la déclaration à l'ARS pour les contacts étroits.

Station 05 : Œdème Aigu du Poumon (OAP) Flash Cardiogénique

Cardiologie & Réanimation • Item R2C 234 • Insuffisance cardiaque de l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Mme Simone, 72 ans, suivie pour cardiopathie hypertensive, admise au déchocage pour détresse respiratoire survenue brutalement à 4 heures du matin. PA = 210/110 mmHg, FC = 120 bpm, SpO2 = 82% en air.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente est en orthopnée stricte, impossible de s'allonger, sueurs froides, polypnée à 35/min, crépitants bilatéraux remontant jusqu'aux sommets, expectoration mousseuse rosée.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Position assise jambes pendantes, monitoring scope cardiotensionnel et oxymétrique.
2 à 4 min	Mise sous VNI CPAP précoce (PPC de Boussignac ou machine de VNI avec PEP 5-10 cmH2O).
4 à 6 min	Prescription de dérivés nitrés IV à dose de charge (Dinitrate d'isosorbide au PSE) pour baisser la post-charge.
6 à 7 min	Diurétique de l'anse IV (Furosémide 40 à 80 mg IVD), recherche du facteur déclenchant (SCA, poussée HTA, fibrillation atriale).

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Installation de la patiente assise les jambes pendantes au bord du lit	2 pts	Rang A
Mise en route précoce de la ventilation non invasive en mode CPAP/PPC	4 pts	Rang A
Traitement vasodilatateur d'urgence par dérivés nitrés IV (Risordan au PSE)	4 pts	Rang A
Administration de furosémide intraveineux (40-80 mg IVL)	3 pts	Rang A
Objectif tensionnel strict : baisse progressive de la PAS sans collapsus	3 pts	Rang A
Prescription de l'ECG 12 dérivations à la recherche d'une ischémie myocardique aiguë	2 pts	Rang A
Recherche étiologique exhaustive : écart de régime sans sel, arrêt de traitement, ischémie, arythmie	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Allonger la patiente pour l'examiner (risque d'asphyxie et d'arrêt cardio-respiratoire immédiat).
■■ **Piège 2 :** Mettre des diurétiques en première intention sans vasodilatateurs chez un hypertendu sévère en OAP flash.
■■ **Piège 3 :** Oublier de vérifier l'absence de prise récente d'inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 avant d'injecter des dérivés nitrés.

Station 06 : Acidocétose Diabétique Inaugurale

Endocrinologie, Diabétologie & Réanimation • Item R2C 247 • Diabète sucré de types 1 et 2 • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Julien, 19 ans, sans antécédent, consulte aux urgences pour douleurs abdominales, vomissements, asthénie intense et amaigrissement de 5 kg en 3 semaines avec soif permanente.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient est somnolent, peau sèche, pli cutané persistant, haleine d'odeur acétonique (pomme reinette), polypnée ample et régulière (Kussmaul) à 26/min. PA = 100/60 mmHg, FC = 115 bpm.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Glycémie capillaire (28 mmol/L = 5.0 g/L) et cétonémie capillaire (4.8 mmol/L), diagnostic d'acidocétose.
2 à 4 min	Mise en condition (2 VVP gros calibre, bilan ionogramme avec kaliémie en urgence, gazométrie veineuse).
4 à 6 min	Réhydratation hydro-électrolytique massive prioritaire (NaCl 0.9% 1L la première heure) et contrôle de la kaliémie.
6 à 7 min	Insuline rapide IVSE (0.1 UI/kg/h) UNIQUEMENT après avoir vérifié que le K+ est > 3.3 mmol/L.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Reconnaissance sémiologique : respiration de Kussmaul, odeur acétonique de l'haleine	3 pts	Rang A
Contrôle immédiat de la glycémie capillaire et de la cétonémie (ou bandelette urinaire)	3 pts	Rang A
Prescription prioritaire de la réhydratation par sérum physiologique 0,9% (1 L/h)	4 pts	Rang A
Règle absolue : vérification de la kaliémie AVANT toute administration d'insuline	4 pts	Rang A
Insulinothérapie par insuline rapide intraveineuse à la seringue électrique (0,1 UI/kg/h)	3 pts	Rang A
Apport glucosé (G5% ou G10%) dès que la glycémie passe sous la barre de 14 mmol/L (2.5 g/L)	2 pts	Rang B
Surveillance rapprochée : iono/glycémie horaire, conscience (recherche d'œdème cérébral)	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Injecter de l'insuline alors que la kaliémie est basse (< 3.3 mmol/L), risquant un arrêt cardiaque par hypokaliémie foudroyante.
■■ **Piège 2 :** Prendre les douleurs abdominales pour une urgence chirurgicale et prescrire une laparotomie (douleurs fonctionnelles de l'acidocétose).
■■ **Piège 3 :** Oublier d'ajouter du glucose dans la perfusion quand la glycémie descend sous 2,5 g/L tout en maintenant l'insuline jusqu'à clairance de la cétose.

Station 07 : Convulsion Fébrille Simple du Nourrisson

Pédiatrie & Neurologie Infantile • Item R2C 344 • Convulsions chez le nourrisson et l'enfant • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Lucas, 16 mois, a présenté une crise tonico-clonique généralisée d'une durée de 2 minutes au domicile dans un contexte de fièvre à 39,2°C. Les parents arrivent très paniqués aux urgences pédiatriques.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Les parents pleurent, pensent que leur enfant a fait une méningite ou va devenir handicapé. L'enfant est réveillé, calme, suce son pouce, souriant, apyrétique post-paracétamol, examen neurologique strictement normal.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Accueil rassurant des parents, évaluation immédiate des constantes et du score de Glasgow pédiatrique (15/15).
2 à 4 min	Interrogatoire précis sur la crise (durée < 15 min, généralisée d'emblée, récupération totale rapide, premier épisode).
4 à 6 min	Examen clinique complet pédiatrique (recherche du foyer infectieux : otite moyenne aiguë pharyngite) et absence de signe méningé.
6 à 7 min	Explication claire du mécanisme de crise fébrile simple, réassurance, conduite à tenir en cas de récidive (Valium intra-rectal si > 5 min).

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Accueil bienveillant, écoute active et apaisement de l'anxiété majeure des parents	3 pts	Rang A
Interrogatoire confirmant les critères de convulsion fébrile simple (< 15 min, généralisée, sans déficit)	3 pts	Rang A
Examen neurologique complet et recherche rigoureuse de signes méningés ou de purpura	4 pts	Rang A
Examen pédiatrique complet recherchant la porte d'entrée fébrile (tympan, gorge, BU)	3 pts	Rang A
Explication claire : absence d'indication d'imagerie cérébrale (TDM/IRM) ni d'EEG en urgence	3 pts	Rang A
Conseils pour le contrôle du confort thermique et posologie exacte du paracétamol (60 mg/kg/j)	2 pts	Rang A
Ordonnance de secours avec Diazépam intra-rectal (0,5 mg/kg) en cas de crise dépassant 5 minutes	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Demander un scanner cérébral ou un EEG en urgence pour une convulsion fébrile simple typique résolue.
■■ **Piège 2 :** Affirmer aux parents que l'enfant est désormais 'épileptique' (confusion grave entre convulsion fébrile et épilepsie maladie).
■■ **Piège 3 :** Négliger de vérifier l'absence totale de raideur de nuque et de purpura chez le nourrisson fébrile.

Station 08 : Torsion du Cordon Spermatique

Urologie & Chirurgie Pédiatrique • Item R2C 343 • Douleur scrotale aiguë de l'enfant et de l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Tom, 15 ans, consulte aux urgences pour une douleur testiculaire droite brutale, survenue il y a 2 heures au repos, d'intensité maximale d'emblée, accompagnée de nausées.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

L'adolescent est replié sur lui-même, marche courbé avec les jambes écartées. Bourse droite rétractée, ascensionnée, testicule horizontalisé et hyperalgique au moindre effleurement.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Examen clinique scrotal bilatéral comparatif : abolition du réflexe crémastérien droit, signe de Prehn négatif.
2 à 4 min	Pose du diagnostic de suspicion clinique de torsion du cordon spermatique (règle des 6 heures).
4 à 6 min	Information claire du patient et de ses parents de la nécessité d'une intervention chirurgicale en extrême urgence.
6 à 7 min	Appel immédiat de l'urologue/chirurgien, consultation anesthésie, mise à jeun strict, bilan préopératoire, antalgiques.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Examen physique scrotal bilatéral et comparatif (position, horizontalisation du testicule)	3 pts	Rang A
Recherche du réflexe crémastérien (aboli du côté douloureux) et signe de Prehn (négatif)	3 pts	Rang A
Poser l'indication chirurgicale formelle d'exploration scrotale en urgence absolue (< 6 heures)	5 pts	Rang A
Règle d'or : ne JAMAIS attendre une échographie-Doppler testiculaire si suspicion clinique	4 pts	Rang A
Mise à jeun immédiate, bilan préopératoire (hémostase, groupe/Rhésus) et voie veineuse	2 pts	Rang A
Information honnête sur l'orchidopexie bilatérale systématique et le risque d'orchidectomie en cas de nécrose	2 pts	Rang B
Prescription d'une analgésie efficace par voie intraveineuse adaptée à l'EVA	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Prescrire une échographie scrotale et différer l'avis chirurgical en attendant l'image (cause numéro 1 de perte testiculaire médico-légale).
■■ **Piège 2 :** Évoquer une orchi-épididymite et renvoyer le patient sous antibiotiques sans avis chirurgical chez un adolescent.
■■ **Piège 3 :** Oublier de préciser que la fixation du testicule controlatéral (orchidopexie bilatérale) est obligatoire au cours de l'intervention.

Station 09 : Métrorragies du 1er Trimestre & Grossesse Extra-Utérine

Gynécologie-Obstétrique & Urgences • Item R2C 24 • Grossesse extra-utérine • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Camille, 26 ans, consulte pour des saignements génitaux peu abondants noirâtres et des douleurs dans la fosse iliaque droite depuis 24h. Elle signale un retard de règles de 3 semaines.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente est inquiète, c'est sa première grossesse voulue. Constantes : PA = 110/65 mmHg, FC = 88 bpm. À la palpation abdominale, sensibilité vive de la fosse iliaque droite sans contracture.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Test de grossesse urinaire rapide au lit du malade ou vérification du test déjà fait (positif).
2 à 4 min	Évaluation hémodynamique stricte et recherche de signes de rupture (défense, pâleur, vertiges, douleur scapulaire).
4 à 6 min	Demande de dosage quantitatif des bêta-hCG plasmatiques et échographie pelvienne endovaginale immédiate.
6 à 7 min	Détermination du groupe sanguin, Rhésus et RAI (prévention de l'allo-immunisation anti-D si Rh négatif).

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Confirmation immédiate de l'état de grossesse par test urinaire ou dosage des hCG	3 pts	Rang A
Évaluation clinique de la stabilité hémodynamique et recherche d'hémopéritoine (cul-de-sac de Douglas)	3 pts	Rang A
Prescription de l'échographie pelvienne endovaginale à la recherche d'une vacuité utérine et d'une masse annexielle	4 pts	Rang A
Dosage quantitatif des bêta-hCG plasmatiques en urgence	3 pts	Rang A
Vérification obligatoire du statut Rhésus et prescription d'immunoglobulines anti-D si patiente Rh négatif	4 pts	Rang A
Explication empathique à la patiente sur les hypothèses (GEU, fausse couche précoce, grossesse intra-utérine évolutive)	2 pts	Rang B
Consigne stricte de maintien à jeun au cas où une laparoscopie exploratrice s'avérerait nécessaire	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Oublier l'injection d'anti-D chez une femme Rhésus négatif avec métrorragies du premier trimestre.
■■ **Piège 2 :** Rassurer faussement la patiente en affirmant qu'il s'agit d'une simple fausse couche sans imagerie endovaginale préalable.
■■ **Piège 3 :** Négliger la douleur scapulaire qui témoigne d'une irritation péritonéale sous-phrénique par hémopéritoine massif.

Station 10 : Monoarthrite Aiguë du Genou (Arthrite Septique)

Rhumatologie & Maladies Infectieuses • Item R2C 198 • Arthrite contemporaine d'une infection • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

M. Gérard, 62 ans, diabétique, consulte pour un genou droit très douloureux, gonflé et rouge depuis la veille au soir. Il est fébrile à 38,7°C et ne peut plus poser le pied au sol.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient grimace au moindre effleurement de la rotule. Genou droit augmenté de volume, chaud, choc rotulien présent, impotence fonctionnelle absolue du membre inférieur droit.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Examen ostéo-articulaire bilatéral, constatation de l'épanchement fébrile, élimination d'une porte d'entrée cutanée.
2 à 4 min	Indication formelle de ponction articulaire immédiate au lit du malade avant toute antibiothérapie.
4 à 6 min	Prescription des analyses du liquide : macroscopie, cytologie avec formule, examen direct Gram, cultures, microcristaux.
6 à 7 min	Mise en décharge du membre, glaçage, antalgiques, hospitalisation en urgence et antibiothérapie IV anti-staphylococcique après ponction.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Poser le diagnostic d'urgence médicale de monoarthrite aiguë fébrile (arthrite septique jusqu'à preuve du contraire)	3 pts	Rang A
Réalisation indispensable d'une ponction articulaire du genou dans des conditions d'asepsie chirurgicale stricte	5 pts	Rang A
Règle absolue : ponctionner impérativement AVANT toute administration d'antibiotique	4 pts	Rang A
Demande complète sur le liquide : cytologie (> 50 000 éléments/mm3), bactériologie (direct et culture), microcristaux	3 pts	Rang A
Prélèvement d'hémocultures systématiques avant traitement antibiotique	2 pts	Rang A
Immobilisation antalgique de l'articulation en attelle sans appui	2 pts	Rang B
Initiation d'une antibiothérapie intraveineuse probabiliste ciblant Staphylococcus aureus (Cloxacilline ou Céfazoline)	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Débuter une antibiothérapie avant d'avoir réalisé la ponction articulaire et les hémocultures.
■■ **Piège 2 :** Infiltrer des corticoïdes dans une articulation infectée suspecte (catastrophe absolue).
■■ **Piège 3 :** Conclure d'emblée à une crise de goutte chez un sujet ayant des antécédents goutteux sans avoir éliminé l'arthrite septique surajoutée.

Station 11 : Consultation d'Annonce de Mauvaise Nouvelle en Oncologie

Cancérologie & Relation Médecin-Malade • Item R2C 290 • Consultation d'annonce d'une mauvaise nouvelle • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Mme Valérie, 48 ans, sans antécédent, vient en consultation pour les résultats de la microbiopsie d'un nodule mammaire ACR 5 découvert au dépistage. Le résultat histologique confirme un carcinome canalaire infiltrant.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente est venue seule, elle est anxieuse mais calme au début. Lorsque le mot tumeur ou cancer est prononcé, elle se met à pleurer silencieusement, se fige et demande si elle va mourir.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Mise en condition (cadre calme, téléphone coupé, assise en face de la patiente), recueil des représentations et du ressenti.
2 à 4 min	Annonce graduelle avec avertissement préalable, mots simples, arrêt immédiat du discours dès les larmes pour respecter le silence.
4 à 6 min	Accueil de l'émotion sans déni, réassurance factuelle sur l'existence de traitements codifiés et curatifs, dossier en RCP.
6 à 7 min	Présentation des étapes suivantes : infirmière coordinatrice du dispositif d'annonce, bilan d'extension, prochain rendez-vous.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Installation adéquate du cadre : bureau isolé, absence de perturbations, contact visuel	2 pts	Rang A
Exploration préalable de ce que la patiente sait ou pressent de ses résultats	3 pts	Rang A
Délivrance d'un signal d'avertissement ('J'ai les résultats de la biopsie, et ils ne sont pas ceux que nous espérions')	3 pts	Rang A
Formulation claire du diagnostic sans ambiguïté mais sans brutalité, en bannissant le jargon médical incompréhensible	3 pts	Rang A
Gestion empathique des émotions : respect des silences, compassion sans promesse irréaliste	4 pts	Rang A
Présentation de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et du programme personnalisé de soins (PPS)	3 pts	Rang A
Proposition de recours à l'infirmière d'annonce et aux soins de support (psychologue, assistante sociale)	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Inonder la patiente de détails techniques de chimiothérapie alors qu'elle vient de s'effondrer en larmes (absence totale d'écoute).
■■ **Piège 2 :** Éviter de prononcer le mot cancer ou laisser planer une ambiguïté rassurante mensongère.
■■ **Piège 3 :** Répondre brutalement 'on ne peut pas savoir vos chances de survie' sans offrir de prise en charge d'équipe coordonnée.

Station 12 : Intoxication Aiguë Volontaire au Paracétamol

Pharmacologie, Toxicologie & Urgences • Item R2C 336 • Intoxications aiguës chez l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Sarah, 21 ans, est admise aux urgences à 17h00. Elle a ingéré à 14h00 (il y a 3 heures) 16 comprimés de Doliprane 1g (soit 16 grammes) lors d'un geste d'auto-agression après une rupture amoureuse.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente est consciente, calme, légèrement nauséeuse mais sans douleur ni ictère. Elle regrette son geste et dit 'je pensais que ça ne faisait que soigner la tête'. Constantes stables.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Vérification précise de l'heure d'ingestion (14h00), de la dose totale supposée ingérée (16g > seuil toxique 150 mg/kg).
2 à 4 min	Planification du prélèvement sanguin pour dosage de la paracétamolémie à partir de H4 (18h00) pour nomogramme.
4 à 6 min	Indication formelle de la N-acétylcystéine (NAC) IV selon le protocole simplifié sans attendre le dosage devant la dose massive.
6 à 7 min	Bilan biologique hépatique (TP, Facteur V, transaminases), surveillance et consultation psychiatrique systématique.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Calcul de la dose supposée ingérée (16 g > 150 mg/kg chez l'adulte, dose potentiellement létale)	3 pts	Rang A
Précision capitale de l'heure exacte d'ingestion (H0 = 14h00)	3 pts	Rang A
Prescription de la paracétamolémie à prélever exactement à partir de la 4e heure post-ingestion (H4 = 18h00)	4 pts	Rang A
Utilisation et interprétation du nomogramme de Rumack-Matthew	3 pts	Rang A
Prescription immédiate de l'antidote spécifique : N-acétylcystéine (NAC) intraveineuse	4 pts	Rang A
Prescription du bilan hépatique complet de départ (Transaminases ASAT/ALAT, TP, Facteur V, créatininémie)	2 pts	Rang A
Organisation impérative d'une consultation psychiatrique dès la levée du risque somatique	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Rassurer la patiente sous prétexte qu'elle est asymptomatique à H3 (l'hépatite cytolytique fulminante n'apparaît qu'à H48-H72).
■■ **Piège 2 :** Attendre le résultat de la paracétamolémie pour débuter la NAC devant une dose déclarée massive > 150 mg/kg.
■■ **Piège 3 :** Laisser sortir la patiente sans évaluation psychiatrique spécialisée après une tentative de suicide avérée.

Station 13 : Baisse d'Acuité Visuelle Brutale et Indolore (OACR)

Ophtalmologie & Médecine Vasculaire • Item R2C 82 • Altération brutale de la vision • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

M. Pierre, 69 ans, consulte aux urgences pour une perte de vue complète de l'œil droit survenue ce matin au réveil sans aucun traumatisme ni aucune douleur oculaire.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient ne voit que des ombres de l'œil droit. L'œil est blanc, indolore, pupille en mydriase aréactive au réflexe photomoteur direct droit (RPM consensuel conservé).

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Examen ophtalmologique sommaire : acuité visuelle effondrée, recherche de douleur oculaire (absente), examen pupillaire.
2 à 4 min	Fond d'œil en urgence : rétine pâle, œdémateuse, blanche laiteuse avec macula rouge cerise (aspect typique d'OACR).
4 à 6 min	Orientation en urgence neurovasculaire / ophtalmologique : tentative de revascularisation si < 4h30, élimination d'une maladie de Horton.
6 à 7 min	Bilan étiologique d'urgence : VS, CRP en urgence, écho-Doppler des troncs supra-aortiques, ECG et avis cardiologique.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Évaluation de l'acuité visuelle et caractérisation de la baisse brutale et indolore	2 pts	Rang A
Examen des réflexes photomoteurs (déficit pupillaire afférent relatif / œil droit)	3 pts	Rang A
Reconnaissance sémiologique du fond d'œil : rétine blanche laiteuse et macula rouge cerise	4 pts	Rang A
Diagnostic positif verbalisé : Occlusion de l'Artère Centrale de la Rétine (OACR) droite	3 pts	Rang A
Prescription immédiate d'une VS et CRP pour éliminer formellement une Maladie de Horton chez un patient > 50 ans	4 pts	Rang A
Prise en charge comme une urgence neuro-vasculaire (équivalent d'AVC ischémique)	2 pts	Rang A
Bilan étiologique complet : Doppler des carotides, ECG (recherche de fibrillation atriale emboligène)	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Oublier de doser la VS et la CRP chez tout patient de plus de 50 ans présentant une OACR (risque de cécité bilatérale irréversible par maladie de Horton non traitée par corticoïdes).
■■ **Piège 2 :** Considérer l'OACR comme un problème purement ophtalmologique bénin et différer le bilan cardiovasculaire.
■■ **Piège 3 :** Prescrire des collyres mydriatiques sans avoir vérifié l'absence d'angle fermé controlatéral.

Station 14 : Pyélonéphrite Aiguë Obstructive Fébrille

Néphrologie, Urologie & Urgences • Item R2C 161 • Infections urinaires de l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Mme Nathalie, 43 ans, consulte aux urgences pour de violentes douleurs lombaires gauches spasmodiques avec frissons et fièvre à 39,4°C. Elle signale n'avoir presque pas uriné depuis le matin.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

La patiente est très algique, agitée (colique néphrétique), frissonnante. PA = 95/55 mmHg, FC = 110 bpm. Douleur lombaire gauche intolérable avec ébranlement lombaire positif.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Identification du syndrome septique fébrile associé à un syndrome obstructif (colique néphrétique fébrile).
2 à 4 min	Reconnaissance d'une urgence médico-chirurgicale absolue : pyélonéphrite obstructive / rein en rétention septique.
4 à 6 min	Imagerie en extrême urgence (Échographie rénale ou TDM abdomino-pelvien sans injection) confirmant la dilatation des cavités.
6 à 7 min	Appel immédiat de l'urologue de garde pour dérivation des urines en urgence (sonde JJ ou néphrostomie) sous couverture C3G IV.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Identification immédiate du tableau de Pyélonéphrite Obstructive (urgence médico-chirurgicale vitale)	4 pts	Rang A
Mise en condition hémodynamique : 2 voies veineuses, remplissage si hypotension, antalgiques IV	3 pts	Rang A
Réalisation d'une bandelette urinaire, ECBU et hémocultures avant antibiothérapie	3 pts	Rang A
Imagerie d'extrême urgence : échographie rénale ou TDM pour objectiver l'obstacle et la dilatation	3 pts	Rang A
Alerte immédiate du chirurgien urologue pour drainage des urines en urgence absolue (sonde double J)	4 pts	Rang A
Prescription de l'antibiothérapie par C3G injectable (Céfotaxime ou Ceftriaxone) associée à un aminoside si choc	2 pts	Rang A
Contre-indication absolue des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en contexte fébrile infectieux	1 pt	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Injecter des anti-inflammatoires (Kétoprofène) pour soulager la colique néphrétique alors que la patiente a 39,4°C (risque de choc septique gravissime).
■■ **Piège 2 :** Traiter médicalement par antibiotiques simples et renvoyer la patiente chez elle sans lever l'obstacle urologique.
■■ **Piège 3 :** Différer l'imagerie au lendemain matin (le rein infecté sous pression détruit le parenchyme rénal en quelques heures).

Station 15 : Évaluation et Prise en Charge d'une Crise Suicidaire Aiguë

Psychiatrie & Médecine Légale • Item R2C 353 • Risque et conduite suicidaires chez l'adolescent et l'adulte • 7 minutes chrono (Lecture consigne : 1 min)

■ CONTEXTE CANDIDAT (Affiché sur la porte) :

Maxime, 24 ans, interne en médecine, est accompagné par un collègue qui a trouvé chez lui une lettre d'adieu après une rupture sentimentale et l'échec à un examen de spécialité.

■ INSTRUCTIONS POUR L'ACTEUR STANDARDISÉ :

Le patient a le regard fuyant, répond par monosyllabes. Il dit 'je suis au bout du rouleau, tout le monde se portera mieux sans moi'. Il admet posséder une boîte de somnifères entamée.

Minutage	Actions Prioritaires & Démarche Clinique
0 à 2 min	Mise en sécurité immédiate (box fermé, aucun objet dangereux, pas de sortie seul), création de l'alliance thérapeutique.
2 à 4 min	Évaluation structurée du potentiel suicidaire selon la grille RUD : Risque (facteurs de vulnérabilité), Urgence (scénario prêt), Dangerosité (moyen létal disponible).
4 à 6 min	Questionnement direct et bienveillant sur les idées de mort, le plan précis et les tentatives antérieures.
6 à 7 min	Décision d'hospitalisation de crise en milieu spécialisé, recherche de soutien des proches (tiers de confiance), contrat de non-passage à l'acte.

Compétence Évaluée & Critères d'Exécution	Points	Rang
Mise en condition sécuritaire immédiate : présence continue, retrait de tout moyen létal potentiel	3 pts	Rang A
Création d'une relation d'écoute empathique sans jugement moral ni banalisation de la souffrance	3 pts	Rang A
Évaluation systématique du modèle RUD : Risque, Urgence du passage à l'acte, Dangerosité du moyen	4 pts	Rang A
Questionnement explicite et direct sur l'existence d'un scénario suicidaire précis et daté	3 pts	Rang A
Décision collégiale d'hospitalisation psychiatrique de crise (libre ou sous soins sans consentement si refus)	3 pts	Rang A
Information et mobilisation d'une personne de confiance ou des proches de l'entourage	2 pts	Rang A
Traçabilité écrite rigoureuse de l'évaluation dans le dossier médical	2 pts	Rang B

■ LES 3 PIÈGES ÉLIMINATOIRES R2C (Pénalités sévères du jury) :

■■ **Piège 1 :** Avoir peur de poser la question directe 'Avez-vous pensé à vous tuer ?' par crainte de 'donner des idées' (mythe faux : le questionnement direct soulage le patient en crise).
■■ **Piège 2 :** Laisser le patient quitter les urgences seul ou avec la simple promesse verbale qu'il 'ira mieux demain'.
■■ **Piège 3 :** Moraliser ou dédramatiser la situation par des phrases condescendantes ('vous êtes jeune, vous allez rebondir').